جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فاطمه محمد احمد عبد الرحيم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** المقطم **العنوان :** مساكن الدلتا
رقم البطاقة : 28201062300389 **رقم التليفون :** 01155098223 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 06-01-1982 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمده 6 شهور [14163] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فاطمه محمد احمد عبد الرحيم
National ID: 28201062300389

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: فاطمه محمد احمد عبدالرحيم **MR. :** 6891	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was prescribed FEMARA 1 mg daily, Calcium 1 tablet daily, ONE ALPHA, and ZOLADEX 10.8 SC, with a planned administration on 11/4/2026, and a dental assessment was ordered in preparation for ZOMETA therapy.

The patient was identified as having breast cancer and was noted to be receiving an aromatase inhibitor (AI) with ZOLADEX administered on the day of the visit.

The patient continued management of breast cancer with FEMARA and ZOLADEX, with both agents administered on the day of the visit, and was advised to continue FEMARA for a total duration of three months.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : nada mohamed elsayed

يعتمد ,

Name : Fatma Mohammed Date : 09-01-2022

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. *Chest:*
   - Reported case of breast carcinoma.
   - Few bilateral pulmonary nodules ranging from 2-3 mm.
   - No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
2. *Abdomen and pelvis:*
   - The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - IUD seen in place.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic masses or collections.
3. *The scanned skeleton:*
   - The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

Post op

MDT FORM

19/6/2022

Name	فاطمة [illegible]	MRN	1290
Age	٤٠ سنة	ID	
Menopausal status		Phone	01155098[illegible]
OCP		marital status	
Co morbidity	NAD	Family history	-ve

Clinical Data

Bx: Mixed Ductal & lobular Carcinoma

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	4/8	-ve	Ki 67

Sonomammography: Limited (Bilateral)

Mets Workup: CAP CT 4/2022 Free from mets

T N M
3 3

Recommendations: Rt MRM was done 12/6/2022
- [illegible]
- T3N3
- free surgical margins

MDT OUTCOME & PLAN: Neoadj & Neoadjs
for Adj EC x4 → docetaxel x4 → Adj
+ Herceptin

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE RADIOLOGY	PATHOLOGY

C.C [illegible]

Patient Name : [illegible]
Patient No : 29201062300389
Path No : 1254/2022
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Dr. :

Request No. : 13003425
Request Date : 15/05/2022
Verification Date : 02/06/2022
Financial Category : اورام دار السلام - فئة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Lt multicentric breast cancer.
Nature of the specimen: Lt MRM.

Gross Examination:
• Received: MRM measured 30x28x6cm, skin ellipse measured 25x17cm.
• Labeled as: UOQ and UIQ
• Tumor(s):
o Number: Two ill-defined greyish white rubbery to firm masses.
o Size: 6.5x2.5cm and 2.7x2x2cm, with 10 cm in between.
o Skin involvement: Grossly unremarkable.
• Distance from margins: UOQ mass away 0.8cm from deep margin, UIQ mass away 1cm from deep margin.
• Lymph nodes number and size: 29 nodules, up to 2cm, with 3 of them were included in a separate container.
• Additional pathologic findings: Rest of breast tissue showed greyish white thickened tissue.

Microscopic examination:
• Histologic type: Bifocal Mixed Invasive Ductal Carcinoma and Invasive Lobular Carcinoma.
• Grade: 2.
• DCIS: Present.
• Calcifications in situ: Minimal < 5%.
• LVI: Present.
• Skin / Nipple / areola: Free Nipple and areola
• Lymph nodes involvement: Positive (17/29) LNs, with capsular infiltration, and focal extension.
• Resection Margins: Free deep margin.

Verified by:
Dr. Menna Nabil

Report Date: 02/06/2022 09:19:44

Printing By : .marwa mohamed youss

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Request No.	: 13003425
Request Date	: 15/05/2022
Verification Date	: 02/06/2022
Financial Category	: اورام دار السلام - تغطية الدولة
Department	: Out Patient
Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Calcifications

- Invasive breast cancer., LUMRM.
- Invasive Ductal Carcinoma and Invasive Lobular Carcinoma, GII, with minimal Ductal carcinoma in situ < 5%.
- Vascular invasion.
- Nipple and areola.
- ... with capsular infiltration, and focal extracapsular extension.

Prof. Lubna Omar
Dr. Menna Atef

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / فاطمه محمد احمد عبدالرحيم	Request No.	: 13009370
Patient No.	: 28201062300389	Request Date	: 08/03/2022
Path No.	: 641/2022	Verification Date	: 06/04/2022
Sex	: Female	Financial Category	: زوار دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yous

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Lt breast mass lesion.

Nature of the specimen:
Tru-cut biopsy.

Gross Examination
• Procedure:Tru-cut biopsy.
Two containers were received:
1-Axillary lymph node: Multiple grayish white tissue core biopsy measured collectively 1.5 cm , totally submitted.
2-Lt breast mass. Multiple grayish white fibrofatty tissue piece measured collectively 1.5 cm, totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:
1-Axillary lymph node:
• Histological type: Metastatic carcinoma compatible with mammary origin.

2-Lt breast mass:
• Histological type: Invasive duct carcinoma.
• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1)
•IPT:
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Moderate nuclear reaction in 10% of tumor cells (Allred score 4/8)

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / فاطمه محمد احمد عبدالرحيم	Request No.	13009370
Patient No.	28201062300389	Request Date	08/03/2022
Path No.	641/2022	Verification Date	06/04/2022
Sex	Female	Financial Category	برنامج علاج للسلام - نفقة الدولة
Age	40 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
Ki 67: 50 % nuclear reaction

Diagnosis:
1-Axillary lymph node, Tru-cut biopsy:
- Metastatis Carcinoma compatible with mammary origin.

2-Lt breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma Grade II.
-ER: Positive(8/8)
-PR: Positive(4/8)
-HER2:Negative (score 0)
-Ki 67: 50 % nuclear reaction

Dr. Menna Atef
Dr. Menna Nabil

Prof.Dr.Gamal Abdelatty

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

مركز بهية للاكتشاف المبكر
وعلاج سرطان السيدات

PATIENT NAME: **FATMA MOHAMMED Ahmed ABD EL RAHIM**
GENDER: **Female**
AGE: **40 y**

PATIENT ID #: **2022201744**
ORDER #: **1831621**
DATE OF SERVICE: **05-Sep-2022 11:21 AM**

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.
Technique:
Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP:
FINDINGS:-
Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.
Arthritic changes at knees and sterno-clavicular joints, more at left sterno-clavicular joint for follow up.
Both kidneys are seen.
Conclusion: -
No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Recommendation
Follow up bone scan is advised.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed **05-Sep-2022 01:40 PM**

- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- *Reported case of breast carcinoma.*
- *Bilateral pulmonary benign tiny nodules.*
- *No definite hepatic or osseous metastatic deposits.*

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. M. Gomaa, M.D.

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

[[DOCTYPE:MDT_FORM]]
MDT Form

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

10/11/2026

MDT FORM

Name:	فاطمه محمد احمد عبدالرحيم	**MRN:**	6891
Age:	45 Y	**ID:**	28201062300389
Menopausal Sta		**Phone:***	01111817469
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
Gender			
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	suspected metastasis
Surgical History:*	mrm 2022	**ECOG Performance Status**	○ 0 ○ 1 ◉ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: idc g2

ER: 8/8 **PR:** 5/8 **HER2:** - **KI67:**

History:

44 yr old female, HTN, a case of left breast cancer, underwent lt MRM in 6/2022 IDC G2 pT3 N3

free surgical margins ER 8/8 PR 5/8 HER2 -, received adj AC X4 Docetaxel x4, PORTH, adj TAM x2 yrs then shifted to AI ~1.5 to 2 yrs ago (no clear timeline)

pt presented with dyspnea and cough > PCCT CHEST > moderate to marked pl effusion with left partial collapse, internal mammary and prevascular LN 2x2.1 mm

CXR > moderate pleural effusion, pleural tapping done twice and cytology shows lymphocyte rich smears

CT CAP requested, for MDT

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

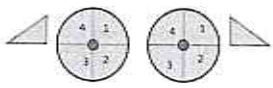
for cdk4/6 /faslodex

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

for cdk4/6 /faslodex if premenopausal to add zoladex

R L



TNM

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د حنان عزت	د احمد نجيب		